Sujet n°3 : SDD 172

Spécialité : Médecine d'urgence

Date : 26/11/2024
Auteur : Cyril COSSE (DES médecine d'urgence)
Relecteur(s) : Clément FILLIOL (DES radiologie)

Domaine d'apprentissage principal	Communication interprofessionnelle
Domaine d'apprentissage secondaire	Urgence vitale
Item(s) en lien avec la station	Item 334 - Prise en charge immédiate pré-hospitalière et à l'arrivée à l'hôpital, évaluation des complications chez : un brûlé, un polytraumatisé, un traumatisé thoracique, un traumatisé abdominal, un traumatisé des membres et/ou du bassin, un traumatisé du rachis ou vertébro-médullaire, un traumatisé crânien ou crânio-encéphalique
Situation(s) de départ en lien avec la station	SDD 172 - Traumatisme crânien
Matériel nécessaire à la station	Aucun
Contexte de la station	Enfant de 3 ans et 10 mois amené par le SMUR pédiatrique pour chute

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction, même partielle, et toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES Anesthésie-Réanimation, Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES Médecine Interne, Paris), Clément FILLIOL (VP ECOS, DES Radiologie, Lyon) et Alexandre DEGACHI (Président, ancien DES Médecine Interne, Paris)

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :

Vous êtes interne de garde en SAUV dans un hôpital général vers 23 heures. Vous accueillez l'enfant Lylou, 3 ans et 10 mois, qui vient de chuter de son lit superposé. Ses parents l'ont retrouvé au sol après avoir entendu « taper au sol ». Ils ont retrouvé Lylou confuse et ont appelé le SAMU. C'est l'équipe du SMUR pédiatrique qui vous amène l'enfant.

Consignes :

Vous devez en 8 minutes :

- Donner les informations pertinentes à collecter auprès de vos collègues du SMUR
- Décrire à l'oral les signes recherchés lors de l'examen clinique
- Proposer une prise en charge diagnostique initiale
- Citer les principales consignes de surveillance d'un traumatisme crânien chez l'enfant

Vous ne devez pas :

- Mettre en place de traitement
- Faire le bilan lésionnel

Attention : Vous avez 8 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales

Toute reproduction, même partielle, et toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.

Sous la supervision de Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES Anesthésie-Réanimation, Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES Médecine Interne, Paris), Clément FILLIOL (VP ECOS, DES Radiologie, Lyon) et Alexandre DEGACHI (Président, ancien DES Médecine Interne, Paris)

ECOS TACFA
GRILLE D'ÉVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques			
1.	Circonstances de la chute dont l'horaire	1 pt	☐
2.	Antécédents de l'enfant	1 pt	☐
3.	Évalue la gravité initiale (au moins 3 éléments) initiale : constantes ; score de Glasgow ; état des pupilles ; hémodynamique	1 pt	☐
4.	Recherche la présence d'une plaie ou d'un saignement lors de la prise en charge initiale	1 pt	☐
5.	Vérifie que la prise en charge soit déjà initiée par le SMUR	1 pt	☐
6.	Neurologique : - Vérification de la plaie suturée du scalp - Recherche d'un traumatisme de la face - Recherche d'un épistaxis	1 pt	☐
7.	Thoracique : - Recherche d'une asymétrie auscultatoire	1 pt	☐
8.	Abdominal : - Palpation et percussion abdominale (recherche de matité ?) - Recherche d'un hématome cutané	1 pt	☐
9.	Rachis : - Palpation du rachis - Installation en monobloc - Vérification de la stabilité du bassin	1 pt	☐
10.	Membres : - Recherche de plaies - Prise des pouls périphériques	1 pt	☐
11.	Prescrit une biologie initiale (au moins 4 éléments) : - Groupe sanguin + RAI - NFS, plaquettes, bilan de coagulation - GDS avec lactate artériel - Ionogramme – urée – créatininémie	1 pt	☐
12.	ECG	1 pt	☐

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction, même partielle, et toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES Anesthésie-Réanimation, Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES Médecine Interne, Paris), Clément FILLIOL (VP ECOS, DES Radiologie, Lyon) et Alexandre DEGACHI (Président, ancien DES Médecine Interne, Paris)

13.	Demande un bilan d'imagerie initial : - Échographie FAST - Radiographie bassin de face - Radiographie thorax de face	1 pt	☐
14.	Utilise un vocabulaire de réassurance Précise les symptômes devant faire reconsulter (au moins 2) : - Altération de la conscience, - Maux de tête, vomissements violents / persistants Rappelle la nécessité de se mettre au repos	1 pt	☐
Communications et attitudes			

15.

12. APTITUDE À PROPOSER UNE PRISE EN CHARGE (situations aiguës / chroniques)

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Est incapable de proposer une prise charge adaptée à la situation clinique	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels, n'arrive pas à justifier la démarche	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels et justifie la démarche.	Propose une prise pertinente. Ne s'attarde pas au traitement/prise en charge inutile et justifie la démarche.	Etablit l'ordre de priorité des différents aspects de la prise en charge du patient (hiérarchise).

16.

11. APTITUDE À PLANIFIER LES SOINS (= approche centrée sur le patient)

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Le projet des soins ne correspond pas au tableau clinique ou ne prend pas en compte le patient et ses besoins	Le projet des soins est adapté au tableau clinique Omet quelque fois de prendre en compte les capacités / contraintes du patient	Fait participer le patient à la planification de ses soins *(ex invite le patient à poser des questions)*	Favorise la prise de décision en partenariat avec le patient.	Favorise la prise de décision en partenariat avec le patient. Renforce la confiance du patient et son autonomie

TOTAL	**16 points**

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction, même partielle, et toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES Anesthésie-Réanimation, Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES Médecine Interne, Paris), Clément FILLIOL (VP ECOS, DES Radiologie, Lyon) et Alexandre DEGACHI (Président, ancien DES Médecine Interne, Paris)

ECOS TACFA
SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ

Pas de patient simulé.

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction, même partielle, et toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES Anesthésie-Réanimation, Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES Médecine Interne, Paris), Clément FILLIOL (VP ECOS, DES Radiologie, Lyon) et Alexandre DEGACHI (Président, ancien DES Médecine Interne, Paris)